

今日课程
即将开始
请您静候





考前串讲课

心理评估概论考点串讲

授课教师：田琪

【本章考情分析】

章节	考点数	历年真题占比	常考题型	掌握程度
初诊接待与资料的搜集、整理	23	28%	单选	★★★★★
初步诊断	6	2%	单选	★
人格测验	15	12%	单选+多选	★★★
心理与行为问题评估	18	17%	单选	★★★
应激及相关问题评估	9	7%	单选	★★
心理评估的作用与方法	8	5%	多选	★
心理测验在心理评估中的应用	13	9%	单选	★★
个案概念化	20	21%	单选+多选	★★★★★

心理评估 概论

C O N T E N T S

一

心理评估

二

初诊接待与资料的搜索、整理

三

初步诊断

四

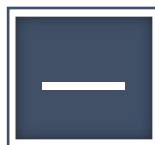
心理测验在心理评估中的作用

五

个案概念化

第一节 心理评估

C O N T E N T S



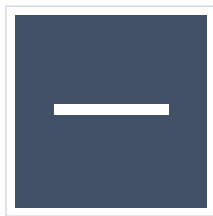
心理评估的定义及作用



心理评估的问题和内容



心理评估的类型



心理评估的定义及作用

多选

考点P40

心理评估是指：

是**描述，记录和解释**个体心理和行为的方法

是利用**观察法、访谈法、测验法**等多种手段获得的信息

对个体心理现象做**全面、系统、深入**的客观描述和解释的过程

一、心理咨询的有效性

多选

考点P40

- 心理咨询师对心理咨询的性质、过程的正确认识;
- 熟练掌握心理咨询的原则、方法和技能技巧;
- **对来访者心理特征、行为问题性质和严重程度的正确评估;**
- 以便于提供适当的指导、帮助和行为矫正训练。

二、在评估过程中心理咨询师的任务

多选

考点P40

收集信息--懂得获得什么信息以及如何获得这些信息

整合信息--懂得有意义地综合

利用信息--利用这些信息形成临床预测和假设，形成咨询计划雏形



三、评估会谈的重要性

多选

考点P40

心理评估对心理咨询师和来访者都很重要：

1. **发现**咨询中发生的**改变**



2. **审查**心理咨询的**效果**



四、评估分类的依据

考点P41

评估可以根据来访者的症状对其心理问题进行，其中：

- 1.包括探讨来访者的情绪，心理及行为问题的可能**成因**；
- 2.还包括为已经界定出的问题找寻合适的**咨询技术**，并且评估这些咨询技术**起效**的可能性。

评估是整个咨询的有机组成部分，是一个不断了解来访者的过程。



心理评估的问题和内容

一、对来访者问题的评估

考点P41

心理评估的内容：

对来访者**心理问题**的评估和**咨询效果**的评估



心理评估的时间：

贯穿在整个咨询过程的**始终**



一、对来访者问题的评估 -- 初步了解、探讨问题原因

考点P42

多选

①解释评估的目的

②确定问题范围

③问题的选择和排序

进行会谈评估的起点

④明确问题行为的组成（认知、情感、行为、情境、关系、躯体）

⑤明确前因⑥明确后果

⑦找出后继获益(潜藏因素)

⑧明确问题强度--严重程度、频度、持续时间 ⑨了解来访者对自己问题的知觉

⑩了解以前的解决方法⑪了解来访者个人及环境中的有利因素



心理评估的类型

多选

考点P44

(一) 概述：从评估的功能上划分：

描述性评估

把观察到的事情或现象描述出来，着重于客观事实的静态描述。也会探讨事物存在的理由及其所隐含的意义。

决策性评估

运用心理测验指导心理咨询师进行评估和分类，并决策用什么样的咨询方法进行干预。

解释/预测性评估

对现有的现象进行描述，对产生的原因进行解释，对将来可能发生的事情进行预测，从而对不期望的现象或结果加以控制。

对来访者心理问题的评估可以帮助心理咨询师对其有初步的了解。

总结

心理评估

定义及作用

定义：描述，记录和解释；观察法、访谈法、测验法；全面、系统、深入

作用：
有效性：性过原方技、特行严矫练
任务：收集、整合、利用
重要性：发现改变；审查效果
分类依据

问题和内容

心理问题：初步了解，探讨问题原因

咨询效果：时间点、咨询目标、六个维度、效果分析

评估时间：贯穿始终

类型

描述性评估

决策性评估

解释性或预测性评估

第二节 初诊接待与 资料的搜索、 整理

一

如何进行初诊接待

二

摄入性会谈

三

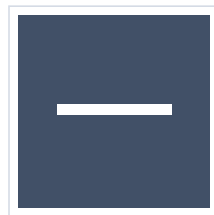
正确使用心理测验

四

一般临床资料的整理和评估

五

了解求助者的既往史，寻找有价值的资料



如何进行初诊接待

考点P47

初诊接待是心理咨询师和来访者的第一次会面，在心理咨询中有重要的作用。**能否建立良好的咨询关系也是保证心理咨询成功的必要条件**

初诊接待中，心理咨询师的工作主要不在于解决求助者的困扰，而在于**提供一个让求助者释放压抑的空间，减轻来访者紧张不安或焦躁疑虑的情绪。**

一、初诊接待的工作程序

(一) 做好心理咨询前的准备工作

1. 合理配置心理咨询场所

- 能显示专业的特点
- 具有保密的功能
- 能提供适当宽敞的空间（10平米）
- 配置舒适的座椅
- 配置必需的设备

一、初诊接待的工作程序

考点P48

(一) 做好心理咨询前的准备工作

2. 表现出心理咨询师应有的仪态

- 仪态：服装整齐、表情平和

3. 保持正常社交距离

- 距离：社交距离



一、初诊接待的工作程序

考点P48

- (二) 使用**礼貌的**接待方式和礼貌的语言
- (三) **间接询问**求助者希望得到哪方面的帮助，不可直接逼问
- (四) 询问结束后，明确表明态度

一、初诊接待的工作程序

考点P49

(五) 向求助者说明**保密原则**

- ▶ **保密内容：**心理咨询过程中求助者暴露的内容
心理咨询过程中与求助者的接触过程

在没有征得来访者同意的情况下，心理咨询师不得随意透露上述信息；心理咨询师也不得随意打探与来访者无关的个人隐私。

一、初诊接待的工作程序

考点P49

(五) 向求助者说明**保密原则**

- ▶ **保密例外**：来访者同意；司法机关要求；涉及伦理或法律诉讼；法律规定的保密问题限制，如报告虐待儿童、老人等；对自身或他人造成即刻伤害或死亡威胁的；患有危及生命的传染性疾病；

涉及到以上保密例外情况时，心理咨询师应将泄密程度控制在最小范围内。

一、初诊接待的工作程序

考点P49

(五) 向求助者说明**保密原则**

► **遵守保密原则的重要性：**

- (1)尊重来访者的自主性；
- (2)体现咨询师的诚信；
- (3)避免对来访者造成伤害；
- (4)使来访者获得安全感；
- (5)利于建立良好的咨询关系。

一、初诊接待的工作程序

多选

考点P49-50

(六) 向求助者说明心理咨询的性质

- ▶ **什么是心理咨询**：是心理咨询师**协助**求助者解决心理问题的过程。在很大程度取决于来访者是否有**主动参与的态度和行动**。
- ▶ **心理咨询如何进行**：心理咨询是一个过程，有些问题**不是一次两次交谈**就能解决的，有时会**迂回曲折甚至反复**，有些问题**甚至难以完美解决**。
- ▶ **心理咨询主要解决什么问题**：解决心理问题，**不能解决哪些问题**。

二、注意事项

多选

考点P50

- ▶ **避免紧张情绪：**按初诊接待的操作步骤进行练习
- ▶ **语言表达：**语速要适中，吐字要清楚，避免使用影响言语交流的方言
- ▶ **反复说明心理咨询中的保密原则：**承诺心理咨询师的责任，并说明一旦由心理咨询师泄密，求助者有诉诸法律的权利。
- ▶ 说明心理测量功能的有限性
- ▶ 心理咨询时，在仪态方面注意不做多余的“下意识动作”

回顾

如何进行 初诊接待

工作 程序

- 1.咨询前的准备工作--咨询室、咨询师
- 2.礼貌的接待方式语言--礼貌招呼
- 3.间接询问，不可直接逼问--“要柔不要刚”
- 4.询问结束后，明确表明态度--“确认过眼神，是我们帮助的人”
- 5.保密原则：内容、例外、重要性--保密or不保密
- 6.向求助者说明心理咨询的性质--助人自助，心理问题
- 7.向求助者说明其权利与义务--资质费用中止，咨询联盟
- 8.与求助者进行协商，确定使用哪种咨询方式--咨询流派和技术

注意事项

避免紧张情绪；语速适中，吐字清楚；
反复说明；测量有限；注意仪态



摄入性会谈

一、会谈法

考点P51

(一) 会谈法的含义

会谈法是心理咨询师必须掌握的基本方法之一。
在20世纪20年代，临床心理学家就把这种方法定义为 **“一种有目的的交谈”**。



一、会谈法

多选

考点P51

(二) 会谈法的要点

- 1.会谈中，听比说更重要
- 2.会谈时的态度

心理咨询师与求助者会谈时，只能持一种**非评判性态度**。

作用：感到轻松、敞开心扉、得到知己

- 如果会谈中出现咨询师非要表明态度不可，不表明态度就无法进行的情况，心理咨询师的态度必须是中性的。表达“理解”是最中性化的和非评判性的态度。它可以使求助者得到知己。

一、会谈法

多选

考点P52

(三) 会谈法的种类

- (1) **摄入性会谈**：了解求助者的客观背景资料，健康/工作/家庭状况等。
- (2) **鉴别性会谈**：通过交谈和观察确定使用什么测验和鉴别措施。
- (3) **治疗性会谈**：针对心理问题和行为问题所进行的会谈。
- (4) **咨询性会谈**：针对健康人的某些问题，如职业选择、人员的任用和解雇、家庭关系问题、婚姻恋爱中的问题、子女教育培养问题等而进行的会谈。
- (5) **应急性或危机性会谈**：当求助者发生意外时，如遭到强奸、想自杀、突然的精神创伤，医生和心理咨询师用会谈法给以帮助。

二、摄入性会谈

考点P52

最常使用的摄入性会谈方式：**背景资料采集法**

人们常选用**桑德伯格**制定的提纲

马隆和沃德于1976年总结出12个题目，作为在会谈过程中了解**求助者精神状态和行为特点**的工作提纲。

桑德伯格提纲

考点P52

- | | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| (1) 人口学资料 | (7) 健康及身体状况 | (13) 社会基础 |
| (2) 求助的原因和期望 | (8) 教育及培训 | (14) 自我描述 |
| (3) 现在及近期的状况 | (9) 工作记录 | (15) 生活的转折点和选择 |
| (4) 对家庭的看法 | (10) 娱乐 | (16) 对未来的看法 |
| (5) 早年回忆 | (11) 性欲的发展 | (17) 求助者附加的任何材料 |
| (6) 出生和成长 | (12) 婚姻及家庭资料 | |

在咨询中，非经来访者同意，不能录音和录像

二、摄入性会谈的工作程序

多选

考点P54-58

- (一) 确定会谈的目标、内容与范围与原则
- (二) 确定提问方式
- (三) 倾听
- (四) 控制会谈内容与方向
- (五) 结束会谈

二、摄入性会谈的工作程序

考点P54

(一) 确定会谈的目标、内容与范围

- 1.求助者主动提出的求助内容
- 2.心理咨询师在初诊接待中观察到的疑点
- 3.依据心理测评结果的初步分析发现问题
- 4.上级心理咨询师为进一步诊断而下达的会谈目标

二、摄入性会谈的工作程序

多选

考点P54

(一) 确定会谈的目标、内容与范围

选择会谈内容的原则：

- (1) 求助者**可接受**：适合求助者的接受能力。
- (2) **有效**：对来访者成长、症状缓解有直接或间接的作用。
- (3) **积极**：对改变求助者的态度有积极作用。

二、摄入性会谈的工作程序

(二) 确定提问方式

心理咨询师根据会谈目的和想搜集的资料内容来确定提问方式。

在心理咨询师还没有真正理解求助者时，最有帮助的办法是把各种封闭性提问变为开放性提问。

二、摄入性会谈的工作程序

考点P55

1.不恰当的提问方式

(1) **为什么.....的问题**：对求助者是有强烈暗示性，可改为“怎样”和“什么”的形式进行提问。

(2) **多重选择性问题**：一个问题多个选择，仍然是**封闭性问题**，使我们获得的信息受限制，可改为开放式提问。

(3) **多重问题**：一次提出多个问题，会使求助者不知所措，也表现出咨询师比较急躁，没有耐心。

二、摄入性会谈的工作程序

考点P56

1.不恰当的提问方式

(4) **修饰性反问**：这样的问题并不构成问题，无法回答也不需要回答，常常使会谈陷入僵局，会把所谈的内容引向空洞和抽象的评价。

(5) **责备性问题**：这是以反问形式责备求助者，会立即引起心理防卫。

(6) **解释性问题**：这是心理咨询师表达自己对问题的看法和理解，而不是推动当事人去自我探索。

二、摄入性会谈的工作程序

多选

考点P56

2.提问过多可能会带来的消极作用

- (1) 造成依赖
- (2) 责任转移
- (3) 减少求助者的自我探索
- (4) 产生不准确的信息
- (5) 求助者可因为处在被“审问”地位而产生**防卫心理**和行为
- (6) 提问过多可以影响会谈中必要的概括与说明

二、摄入性会谈的工作程序

考点P56

(三) 倾听

倾听中不能随便打断求助者谈话，**不随便插入自己的评价。**

倾听中边听边思考求助者诉说内容的逻辑性，判断是否符合常理，及时把握关键点。

二、摄入性会谈的工作程序

多选

考点P57

(四) 控制会谈内容与方向

1.**释义**：又称内容反应，重复求助者话语的重要部分。

释义+提出另一个问题。 **(最常用)**

2.**引导**：指由原来的话题引申出新话题。

3.**中断**：指在会谈中暂时休止一下。如：倒杯水、拿个东西等。

4.**情感反射**：咨询师有意识地刺激求助者，使会谈转向某类问题。

初次会谈时尽量不使用。
“义导断情”

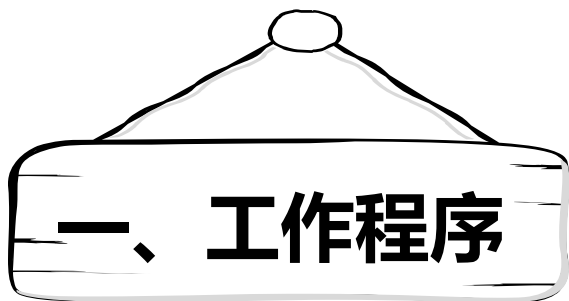
总结

摄入性会谈

- (一) 确定会谈的目标、内容与范围--积极、有效、可接受
- (二) 确定提问方式--为多多修责解，依赖转移不探索
- (三) 倾听--用心听，不随便评价
- (四) 控制会谈内容与方向--“义导断情”
- (五) 结束会谈--总结反馈，下次再约



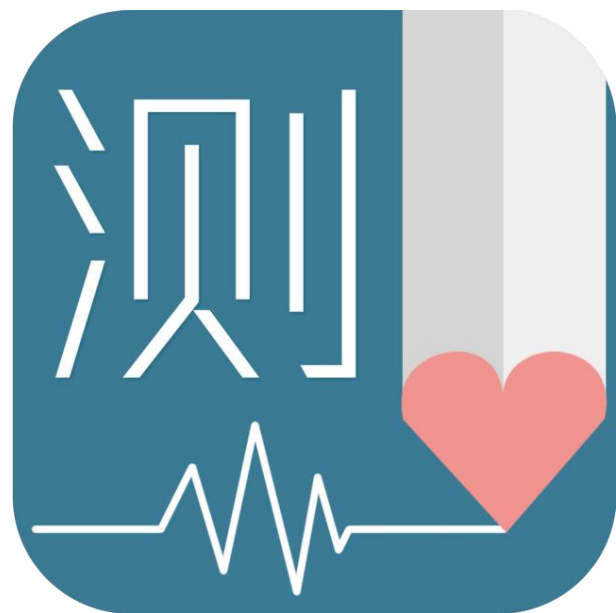
正确使用心理测验



一、工作程序

考点P58

1. **向求助者说明选用量表对确诊的意义并征得求助者同意。**
2. 依据求助者心理问题的性质，选择恰当的心理测验项目。
3. 测量结果如果与临床观察、会谈法的结论相左，不可轻信任何一方，必须重新进行会谈，尔后再进行测评。



二、选择合适量表

考点P59

- 1.选择测评量表应有针对性
- 2.为寻找心理问题的原因而使用量表（SRRS）；为探索求助者行为的倾向性（16PF）
- 3.为评估临床症状严重程度而使用量表（SCL-90、SAS、SDS、MMPI）



三、注意事项

多选

考点P59

1.不得乱用心理测验。

目的不明确依据不充分、单纯依据心理测验结果、未查明某种心理测验自身可靠性、在诊断目的以外使用心理测验、不按心理测验的程序和规定实施、主观对测验数据和结果进行解释、使用盗版软件实施心理测验、使用直接翻译而未修订的测验工具。



三、注意事项

多选

考点P59

2.不得使用“地毯式轰炸”方式实施心理测验。

比如，各种测验工具一起实施，抛弃会谈与观察，径直全部使用心理测验来寻求线索；或者违背职业道德，为了经济利益而大量地、目的性不强地使用心理测验等





一般临床资料的整理与评估

二、临床资料的相关内容

考点P63

(一) 判断资料来源的可靠性，并予以说明

♥ 资料的可靠性是解释资料的先决条件

资料可不可靠？要去验证

有些报告临床情况的人不是来访者自身，而是其亲友或者转诊的中介人。在整理资料时，这些资料应首先判断其真实程度并给予附加说明后，方可使用。

二、临床资料的相关内容

考点P63

(一) 判断资料来源的可靠性，并予以说明

验证临床资料可靠性的办法：

- 使用**补充提问**进行验证
- 使用问卷和心理测验
- 比较同一资料的不同来源





二、临床资料的相关内容



考点P65

(三) 按资料的性质和不同的搜集途径进行分类整理

2.按不同搜集途径划分

一、由不同途径搜集到的临床资料（与求助者临床症状相关的）	主诉 (对症状的自身体验)	主诉内容一	主诉内容二	主诉内容三
	家属报告	与主诉一相关的报告内容	同左	同左
	摄入性会谈	与上两项相关的内容	同左	同左
	临床观察	与上三项相关的内容	同左	同左
	心理测验	与上四项相关的内容	同左	同左
	作品分析	与上五项相关的内容	同左	同左
	其他			
二、资料纵向比较，验证可靠性				
三、临床症状与相关因素之间的联系（说明是因果关系或横向影响关系）				



了解求助者的既往史，寻找有价值的资料

一、工作程序

多选

考点P66-67



1.询问求助者以往**是否去过医疗机构**，详细阅读就诊的病历和有关资料。

2.询问求助者以往**是否去过其他心理咨询机构**，其心理咨询过程如何。



总结

初诊接待与资料的搜集、整理

如何进行初诊接待

工作程序：八步

注意事项：五条

摄入性会谈

确定会谈的目标、内容与范围、提问方式

倾听、控制会谈内容与方向、结束会谈

正确使用心理测验-不乱用，不地毯式轰炸，不一致时再次会谈

一般临床资料的整理与评估

不同提纲整理归纳

临床资料相关内容

资料整理注意事项

了解求助者的既往史，寻找有价值的资料

第三节 初步诊断

C O N T E N T S

一

确定求助者的问题
是否属于心理咨询的工作范围

二

对求助者形成初步印象、
对一般心理健康水平进行分析

三

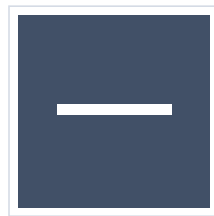
确定造成求助者心理与行为问题的关键点

四

作出诊断

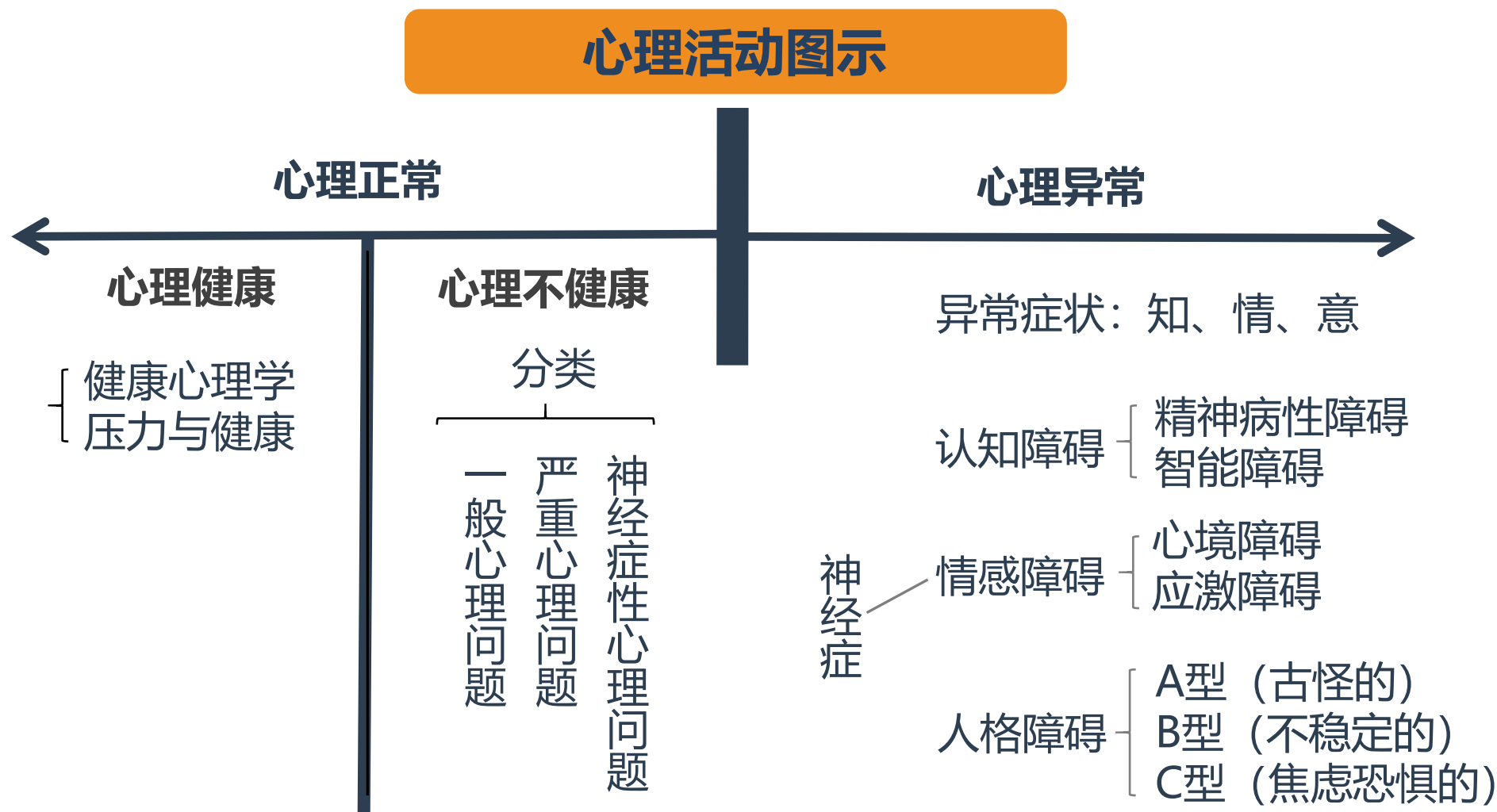
五

提出心理评估报告



确定工作范围

确定工作范围



确定工作范围

多选

考点P70

- 1.理论上，心理咨询的主要对象是心理不健康状态。
- 2.**对精神病性问题，心理咨询师只能进行辅助性工作。**
- 3.慎重对待神经症性心理问题和神经症的求助者。
 - **一些精神病性问题的早期症状可能不典型；而一些神经症性问题也会出现某些思维和行为的异常，心理咨询师要全面综合地分析所获得的各项资料，透过现象看本质，力求做出早期诊断。如有困难，应及时采取会诊或转诊措施。**
- 4.综合分析和鉴别精神病性问题和神经症性问题。
- 5.**明确自己的胜任力，取得相关资质。**



不属于心理咨询范围问题的处理

心理咨询师必须明确自己的工作范围。因为有些问题即使和心理有关，它也不是心理咨询所能解决的，有些问题心理咨询可能只是部分地起作用。对此，心理咨询师要有自知之明，不能包揽一切。



(二) 对来访者具有典型意义的某些特异行为表现进行定性

典型的异常心理行为具有诊断和鉴别诊断意义。

典型症状：周期性发作的抑郁或抑郁与躁狂的交替发作——躁郁症

求医行为：神经症患者求治愿望强烈，主动求医，精神病性问题患者很少主动求医。

自知力：**精神病性患者无自知力；神经症患者有自知力。**



形成初步印象

多选

考点P76

初步印象：心理咨询师对求助者的临床资料进行整理分析之后，对求助者的**心理和行为问题**，形成大致判断。



二、注意事项

考点P76

第一，心理诊断中，应避免“贴标签”，要以现实的临床表现为依据。

第二，对难以确定诊断的案例，
力争通过会诊解决问题。





确定问题的关键点

引发临床表现的关键点

多选

考点P76

- 1.该因素是多数临床表现的**原因**或者与多数临床表现有**内在联系**。
- 2.该因素在个体发展中**持久存在**，并随着生活环境的变化改变自身的形式，但其本身性质不变。





作出诊断

● 一般心理问题诊断

诊断程序：

1. 排除器质性病变
2. 排除精神病性问题
3. 排除神经症性问题
4. 排除严重心理问题
5. 叙述心理问题持续时间、心理、生理及社会功能受损情况
6. 初步诊断为一般心理问题



诊断必须满足4个条件

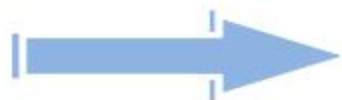
诊断依据：

1. 由现实因素引发产生的**常形**内心冲突
2. 病程**1-2个月**
3. 在理智控制范围内，基本维持社会交往，但**效率有所下降**
4. 自始至终，不良情绪的激发因素仅仅**局限于最初事件**

● 严重心理问题诊断

诊断程序：

1. 排除器质性病变
2. 排除精神病性问题
3. 排除神经症性问题
4. 分析情绪泛化的具体表现
5. 叙述心理问题持续时间、心理、生理及社会功能受损情况
6. 初步诊断为严重心理问题



诊断必须满足4个条件

诊断依据：

1. 较为强烈、对个体威胁较大的现实刺激产生的**常形**内心冲突
2. 病程**2-6个月**
3. 短暂失去理智；依靠自己或**非专业干预难以解脱**；社会交往有一定程度影响
4. 痛苦情绪只要与最初刺激类似同样引发，即反应对象**泛化**

二、严重心理问题

考点P82

(二) 严重心理问题诊断的注意事项

1. **严重心理问题的诊断,要力求与神经症性心理问题相鉴别。**
2. **心理冲突的性质**,对鉴别诊断有重要意义。
3. 通常情况下,对青年人来说,关系到个人发展前途的事件,大致都属于高强度刺激。
4. 在分析情绪是否泛化时,要注意区分泛化与心境对人的影响的区别。心境的关键在于持续,而泛化的关键在于诱发。

三、神经症性心理问题（可疑神经症）

神经症性心理问题诊断的工作程序

1. 分析求助者问题是否有器质性病变做基础
2. 根据区分正常与异常的心理学原则，分析求助者自知力及有无精神病性症状，与精神病性问题相鉴别；
3. 分析求助者的内心冲突类型，确定是否为变形冲突；
4. 确定求助者的病程、精神痛苦程度及社会功能影响程度，与神经症相鉴别；
5. 形成初步诊断

三、神经症性心理问题（可疑神经症）

神经症的打分（许又新）

		1分	2分	3分
病程		不到3个月	3个月到1年	1年以上
人际关系 工作效率	痛苦程度	自愈	他助	无法
	社会功能	轻微	显著（减半）	严重（停止）

考虑三个月

总分=3分，不能诊断为神经症

总分=4或5分，可诊断为神经症性心理问题（可疑神经症）

总分≥6分，可诊断为神经症

总结

初步诊断

确定造成求助者心理与行为问题的关键点--**核心病根，与多数表现有联系**
对求助者形成初步印象、对一般心理健康水平进行分析--**初步印象，现实依据**
确定求助者的问题是否属于健康心理咨询的工作范围--**确定工作范围，明确胜任力**
一般心理问题的诊断--**近期发生、原因明确、反应不强**
严重心理问题的诊断--**内心冲突的性质**
提出心理评估报告--**灵活成文**

第四节 心理测验在 心理评估中 的作用

一

心理状况及自我意识等相关问题的评估

二

自杀危险因素评估

三

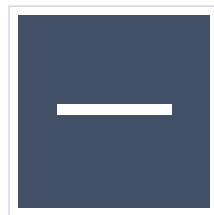
情绪和情感及相关问题的评估

四

人格特征的评估

五

应激以及相关问题的评估



心理状况及自我意识等相关问题的评估

心理状况及自我意识等相关问题的评估

多选

考点P95

心理咨询师要了解来访者心理健康水平以及自我功能状况，包括：

来访者基本的感知觉、认知、外表，语言和思维；
情感和心境，定向力和意识；
判断力和自知力；
现实检验能力等



一、 MMPI 明尼苏达多相人格测验

(一) MMPI测验的基本信息

测验名称：Minnesota Multiphasic Personality Inventory，简称MMPI

测验功能：人格

编制者：明尼苏达大学教授哈特卫和麦金利

编制方法：经验效标法

题目数量：566个自我报告形式的题目，其中16个题目为重复题，如果只为了精神病临床诊断使用，可做前399题。

适用范围：年满16岁、具有小学毕业以上的文化水平

施测形式：卡片式（个别）、手册式（个别+团体）

MMPI共566个题目，其中16个为重复题

基础量表(前399题，为精神病临床诊断而用) 内容量表(后167题)

效度量表
Q L F K

临床量表

Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

(二) MMPI 量表及其意义

MMPI的四个效度量表

Q量表

- ①名称：用？表示，疑问量表
- ②构成：对问题毫无反应及对“是”和“否”都进行反应的项目数
- ③功能：高分者逃避现实

566版,原始分超过30,测验无效;399版,原始分超过22,测验无效

L量表

- ①名称：说谎量表
- ②构成：由过分尽善尽美的项目构成，共15个题目
- ③功能：高分者想让别人把自己看得比实际情况更好

原始分超过10,测验无效

(二) MMPI 量表及其意义

MMPI的四个效度量表

F量表

①名称：诈病量表

②构成：由荒唐古怪（稀有认同）的项目构成，共64个题目

③功能--**高分解释：**

A.(当测验无效) 高分表明受测者答题不认真,理解错误(因智力低下)

高分表明受测者可能伪装疾病

B.(当测验有效) 分数越高，反应精神病的严重程度越高

K量表

①名称：校正量表

②构成：由反应自我控制和家庭问题及人际关系的项目构成，30个题目

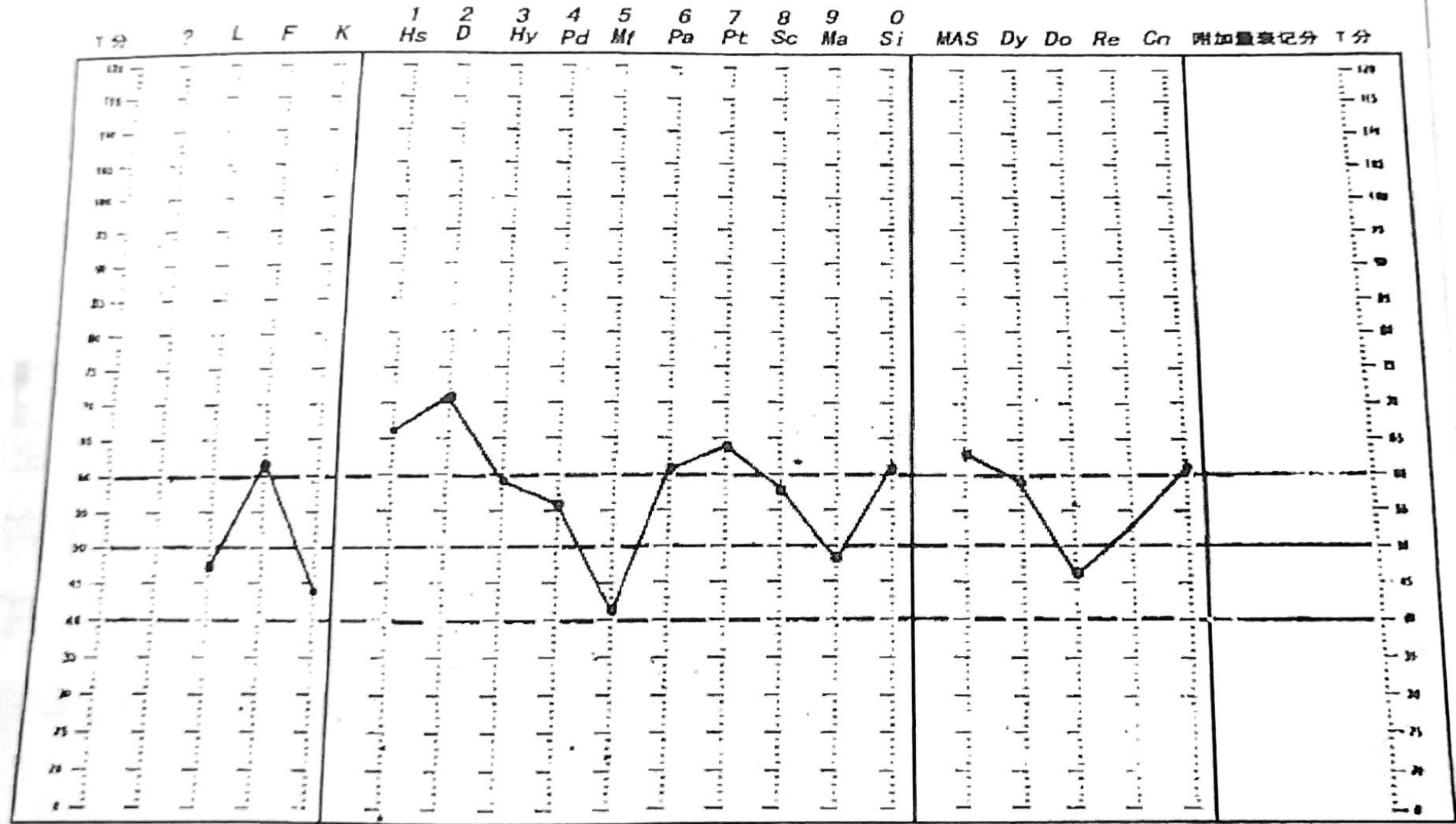
③功能：A.反应受测者态度，是隐瞒的或防卫的

B.计算某些临床量表原始分的K校正分-- $K校正分 = X + nK$

(三) MMPI测验的施测、记分

MMPI基础量表的施测过程		
指导语		* * *
填 写		以目前情况为准
记分	获得原始分	两种记分方式--微电脑记分 模板记分(14张模板)
	转换导出分	在5个量表的原始分数上加一定比例的K分 通过查表, 先将各分量表的原始分转换成T分数 再将各量表T分数登记在剖析图上 $T=50+\frac{10(X-\bar{X})}{SD}$
解 释		中国常模, T分≥60 美国常模, T分≥70





原始分 0 4 18 10 18 39 28 21 35 17 30 31 16 45 30 36 14 23 29 _____

加 K 分 23 25 40 41 18

T 分 47 62 44 66 71 59 56 41 61 64 58 48 61 63 59 46 53 61 _____

(四) MMPI结果的解释

分量表的T分在40-60分为正常，30-40分和60-70分为轻度异常，30分以下和70分以上为显著异常。在实际使用中，**T分在60分以上（中国常模），可能有病理性异常表现或某种心理偏离现象**，低分40分以下不做研究，无意义。

注：MMPI分量表的高分解释，**T分在70分以上（按美国常模）**，即可能为异常。

T分

30分以下：显著异常

30～40分：轻度异常

40～60分：正常

60～70分：轻度异常

70分以上：显著异常

(五) 对MMPI的评价

优点：①鉴别各种精神病患者，临床诊断的符合率较高
②首次将效度量表纳入人格测验，提高了测验的诊断价值

缺点：①项目较多
②时间很长
③考虑受测者受文化背景影响

(六) MMPI的注意事项

第一，进行测验之前，告知受测者MMPI测验的重要性以及对他的好处，以便得到他的合作。

第二，应该向测者讲清楚，如果他遇到什么问题不能回答，可以空下来，但应尽量回答，不要让空着的问题太多。

第三，如果受测者问“有些想法以前有过，而现在没有了，该如何作答”时，可以告诉他**以目前情况为准**。

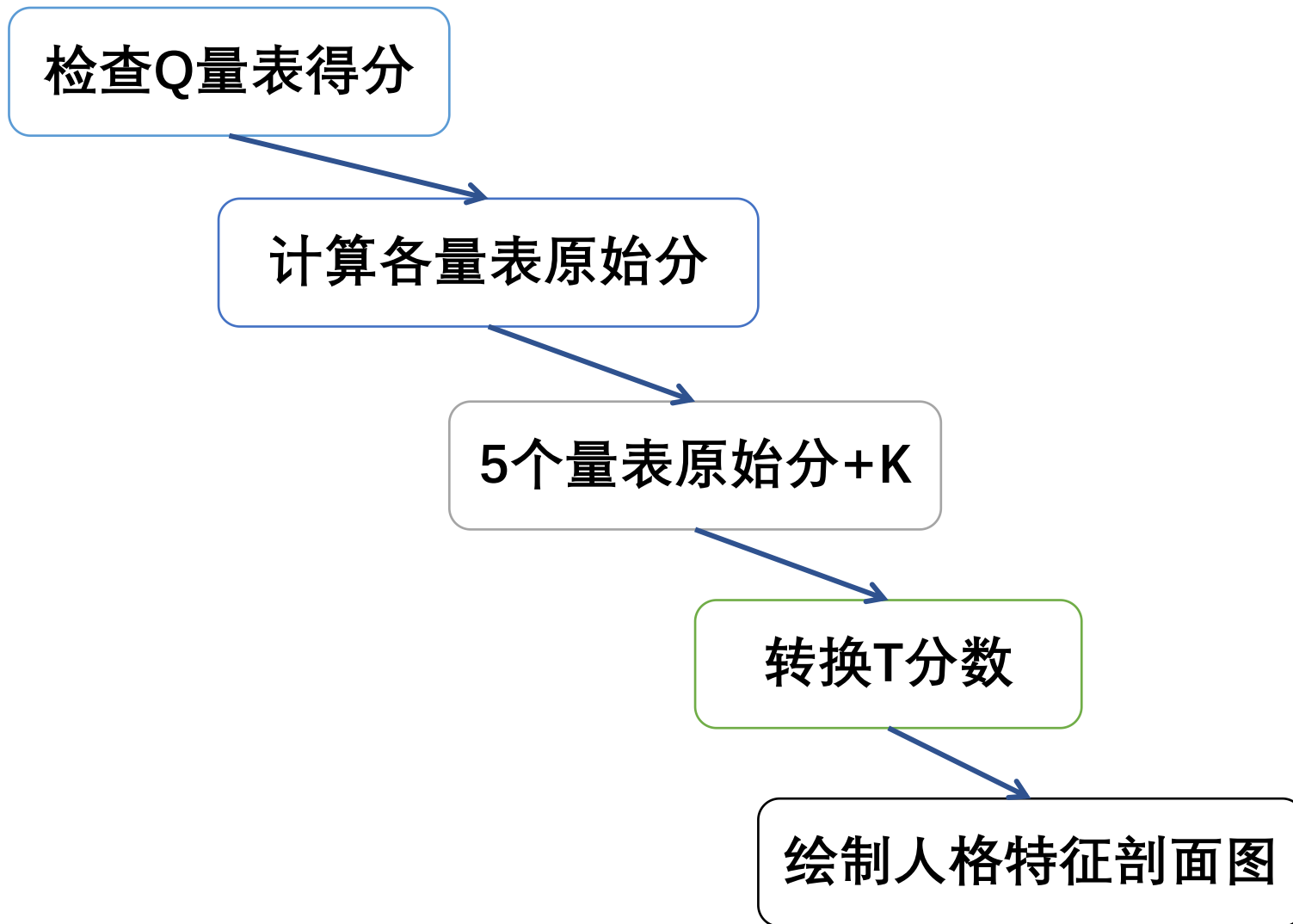
第四，若不耐烦，可分为几次完成，也可录音或将题目读给受测者听。

第五，最好用英文缩写字母或者数字符号，而不要直接使用中文全译名称。

总结

测验名称	MMPI
中文名称	明尼苏达多相人格测验
题目数量	566, 16个重复, 前399用于临床诊断
适用范围	年满16岁, 小学以上文化
编制方法	经验效标法
评定范围	以目前情况为准
量表内容	4个效度量表: QLFK 10个临床量表
解释	中常模60 美常模70
优缺点	优点: 临床符合、首加效度 缺点: 题多时长, 文化影响
其他	Q: 高分逃避现实, 566-30, 399-22 L: 原始分超过10, 无效 F: 有效高分, 严重精神病 无效高分, 不认真、装病

总结 MMPI 记分流程



二、 症状自评量表 (SCL-90)

(一) SCL-90测验的基本信息

测验名称：Symptom Checklist 90，简称SCL-90，又称症状自评量表

编制者：德若伽提斯

测验功能：包含广泛的精神症状学内容

采用**10个因子**分别反映10个方面的心理症状

题目数量：90个题目

适用范围：①在精神科和心理咨询门诊中，了解来访者的心理卫生问题

②在综合性医院，了解躯体疾病患者得精神症状

③了解不同职业群体的心理卫生问题

施测形式：自评；**5级评分** “没有1-很轻2-中度3-偏重4-严重5”

(二) 简要解释

1	躯体化	12	主要反映主观的躯体不适感
2	强迫症状	10	与临床强迫症的症状、定义基本相同(强迫与反强迫并存)
3	人际关系敏感	9	个人的不自在感和自卑感
4	抑郁	13	与临床上的抑郁症状群相联系
5	焦虑	10	与临床上的焦虑症状群相联系

(二) 简要解释

6	敌对	6	从思维、情感及行为三方面来反映 包括厌恶、争论、摔物，直到争斗和不可遏制的冲动爆发
7	恐怖	7	与传统的恐怖症状或广场恐怖基本一致
8	偏执	6	主要指思维方面 如投射性思维、敌对、猜疑、关系妄想、被动体验与夸大等
9	精神病性	10	其中有幻听、思维播散、被控制感、思维被插入等 反映精神分裂样症状的项目
10	其他	7	主要反映睡眠及饮食状况

(三) SCL-90测验的记分

指导语

说明问卷填写方法、注意事项等

填 写

评定的时间范围是“**现在**”或“**最近一周**”的实际感觉

记 分

统计指标--①**总分**：90个项目**单项分相加之和**，能反映其病情严重程度

②**因子分**：该因子项目总分/项目数

每一因子反映某一方面的情况和症状分布特点

阳性项目数：**单项分 ≥ 2** 的项目数，表示受测者在多少项目上有“**症状**”

阴性项目数：单项分=1的项目数，表示受测者在多少项目上无“**症状**”

(四) SCL-90结果的解释

考虑筛选阳性 (需进一步检查) 的情况:

① “1-5” 5级 : 总分 ≥ 160 没有、很轻、中度、偏重、严重

“0-4” 5级 : 总分 ≥ 70

② 阳性项目数 > 43 项

③ 任一因子分 > 2

三、自尊量表 (SES)

共10项，评价一个人对自己的态度，得分越高，自尊程度越高

<https://wenku.baidu.com/view/198718a876eeaeaad1f330f3.html>



自杀危险因素评估

1.自杀危险的主要因素

行为方面：来访者在近期内有过自我伤害或自杀未遂的行为；来访者和别人讨论自杀的方法

认知方面：来访者透露对人生的悲观情绪，甚至表露过自杀的意愿

人际方面：来访者不愿意与别人讨论自杀的问题；有自杀、危险性的来访者不愿意接受医疗照顾；

疾病方面：有抑郁情绪（情绪突然好转）、精神疾病、物质依赖等情况的来访者

家族史：自杀家族史

对于特定来访者，即使没有这些因素也并不能保证其没有自杀冲动

2.自杀相关量表

再次自杀风险量表

- ▶ 共6项，**侧重于精神疾病的来访者再次自杀风险大小的评估**

自杀未遂后风险评估量表

- ▶ 共6项，重点用于评估以前的自杀企图

自杀清单表-SAD PERSONS

- ▶ 共10项，可以辨别自杀风险程度



情绪和情感及相关问题评估

咨询师评估来访者情绪问题时的关注点：

- 1、自述的情绪或情感状态
- 2、言语和非言语行为背后隐藏的核心情绪

来访者**对自己**情绪感受和内在冲动的体验

对情绪的耐受性

情绪转换的灵活性

- ♥ **焦虑是所有焦虑障碍**（广泛性焦虑、惊恐发作、恐怖症、PTSD）**的核心成分**
- ♥ **抑郁是心理咨询中最常见的情绪，绝大多数来访者多多少少都些抑郁的情绪**

一、焦虑自评量表（SAS）

（一）SAS测验的基本信息

测验名称： Self-Rating Anxiety Scale，简称SAS

测验功能： 评定焦虑症状的轻重程度

题目数量： 20个题目（15个正向评分，5个反向评分）

适用范围： 具有焦虑症状的成年人

施测形式： 自评，4级评分

时间范围： 根据**最近一周的实际感觉**进行答题

一、焦虑自评量表 (SAS)

(三) SAS测验的记分

正向评分题：依次评为粗分1、2、3、4分

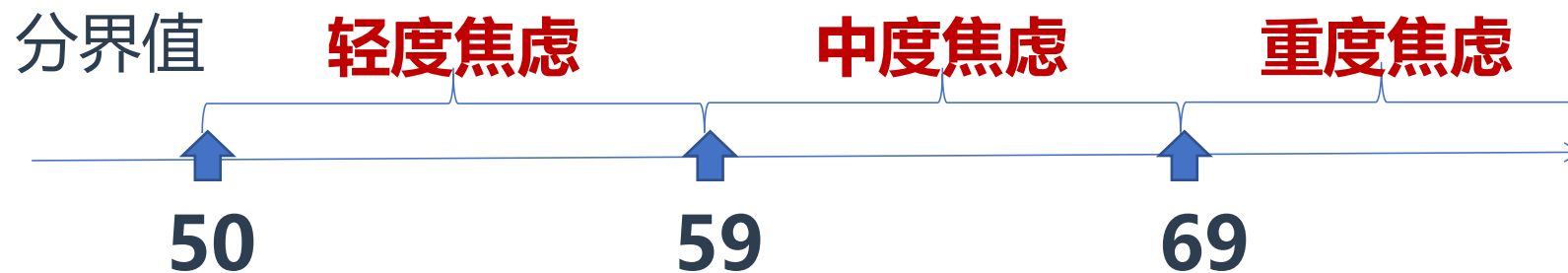
反向评分题：依次评为粗分4、3、2、1分

20个项目得分相加，得到总粗分，乘以1.25，取整数部分。最后得到标准分。

一、焦虑自评量表 (SAS)

(四) SAS结果的解释

按**中国常模**，SAS标准分的分界值为50分



三、抑郁自评量表（SDS）

多选

考点P110

（一）SDS测验的基本信息

测验名称： Self-Rating Depression Scale，简称SDS

测验功能： 评定抑郁症状的轻重程度

题目数量： 20个题目（10个正向评分，**10个反向评分**）

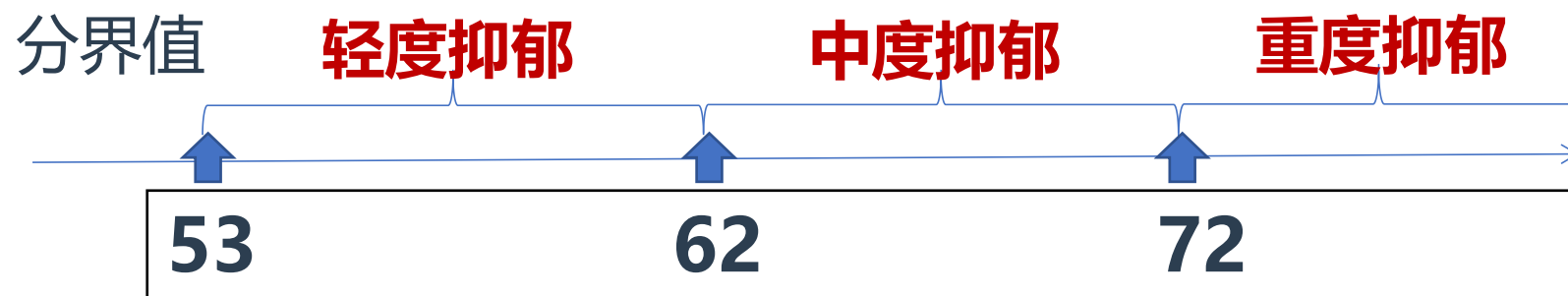
适用范围： **具有抑郁症状的成年人**

施测形式： 自评，4级评分

时间范围： 根据**最近一周**的实际感觉进行答题

(四) SDS结果的解释

按中国常模，SDS标准分的分界值为53分



四、Beck抑郁问卷 (BDI)

- ▶ **共21项Beck抑郁问卷。简称BDI，将抑郁表述为21个“症状—态度类别”**
- ▶ 包括心情、悲观、失败感、不满、罪感、惩罚感、自厌、自责、自杀意向、痛哭、易激惹、社会退缩、犹豫不决、体象歪曲、活动受抑制、睡眠障碍、疲劳、食欲下降、体重减轻、有关躯体的先占观念和性欲望减退。
- ▶ 每类都分四级评分，总分范围0-63分。判断抑郁程度可以参考以下标准：
≤4分，无抑郁或极轻微；5-13分，轻度；14-20分，中度；≥21分，重度。

<https://wenku.baidu.com/view/c0e23fe981c758f5f61f673f.html>

总结

测验名称	SCL-90	SAS	SDS	BDI
中文名称	90项生活症状清单	焦虑自评量表	抑郁自评量表	Beck抑郁问卷
评定范围	现在或最近一周	最近一周	最近一周	
测验记分	总分和因子分	4级评分	4级评分	4级评分
解释	1-5级，总分超过160 0-4级，总分超过70 因子分 > 2 阳性项目数超过43，筛选阳性	中国常模50	中国常模53	总分范围0-63分
其他	总分反应病情严重程度 阳性项目数：单项分≥2，有“症状”	15个正向评分， 5个反向评分	10个正向评分， 10个反向评分	将抑郁表述为21个 “症状—态度类别”



人格特征的评估

一、卡特尔16种人格因素测验 (16PF)

多选

考点P113-114

(一) 16PF测验的基本信息

测验名称：16 Personality Factor Questionnaire, 简称16PF

编制者：**卡特尔**

测验功能：人格

编制方法：**因素分析法**

题目数量：**187个题目**（每个测验有3个选项，为**折中是非题**）

施测形式：手册式（个别、团体）

填写方式：自评

适用范围：**相当于初中以上文化程度的青、壮年和老年人都适用**

应用领域：**可以测量更多方面的人格特质；了解心理障碍的个性原因及心理疾病诊断的重要手段；用于人才选拔。**

(二) 16PF测验的记分

16PF的施测过程		
指导语		* * *
填 写		➤ 先做完4个例题 ➤ 每题有3个备选答案，答案无好坏之分 ➤ 答题要求：每题只选1个，不要漏选，少选中性答案 ➤ 没有时间限制
记分	获得原始分	利用2张模板记分，每张模板为8个量表记分 聪慧性二级记分 其他因素三级记分
	转换导出分	通过查表，先将各分量表的原始分转换成标准十分【5.5， 1.5】 再将各量表标准十分登记在剖析图上
解 释		根据高低分特征解释： 1 ~ 3分为低分 8 ~ 10分为高分

(三) 16个因素的名称和高分、低分人格特征

(因素A)乐群性-- 乐于社交的程度(是否乐于和群体在一起)
高分: **外向、热情**, “**环性情感**” “**高情感**”
低分: 孤独、冷淡, “**分裂情感**”

(因素E)恃强性-- 对他人的支配性(在人际关系中是否强势)
高分: 在与其他人的关系中处于支配地位
低分: **谦逊、顺从、通融、恭顺**

(因素Q1)实验性-- 改革性或激进性(改革--社会实验)
高分: **自由、激进、不拘泥于现实**
低分: 保守传统

人格因素		低分者特征	标准十分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										高分者特征
A	乐群性	缄默孤独	A										乐群外向
B	聪慧性	迟钝、学识浅薄	B										聪慧、富有才识
C	稳定性	情绪激动	C										情绪稳定
E	恃强性	谦逊顺从	E										好强固执
F	兴奋性	严肃审慎	F										轻松兴奋
G	有恒性	权宜敷衍	G										有恒负责
H	敢为性	畏怯退缩	H										冒险敢为
I	敏感性	理智、着重实际	I										敏感、感情用事
L	怀疑性	信赖随和	L										怀疑、刚愎自用
M	幻想性	现实、合乎成规	M										幻想、狂放不羁
N	世故性	坦白、直率、天真	N										精明能干、世故
O	忧虑性	安详沉着、有自信心	O										忧虑抑郁、烦恼多端
Q ₁	实验性	保守、服从传统	Q ₁										自由、批评激进
Q ₂	独立性	依赖、随群附众	Q ₂										自立、当机立断
Q ₃	自律性	矛盾冲突、不明大体	Q ₃										知己知彼、自律严谨
Q ₄	紧张性	心平气和	Q ₄										紧张困扰



(四) 卡特尔的人格理论

个别特质：每一个人所具有的独特特质

共同特质：一个社区或一集团的成员都具有的

表面特质：一个人经常发生的、从外部可以直接观察到的行为表现

根源特质：是通过因素分析方法发现的，是制约着表面特质的潜在基础

特质起源：**素质特质 环境铸模性特质**

特质功能：**动力特质、能力特质、气质特质**

(五) 16PF的应用 (补充内容)



次元人格因素

1. 适应性与焦虑性
2. 内向性与外向性
3. 感情用事与安详机警
4. 怯懦性与果断性



特殊演算公式

1. 心理健康的人格因素
2. 事业有成的人格因素
3. 创造力强的人格因素
4. 有成长力的人格因素

总结

测验名称	16PF
中文名称	卡氏16种人格因素测验
题目数量	折中是非题
适用范围	相当于初中以上
编制方法	因素分析法
评定范围	以现在为准
量表内容	16种根源特质 乐群性-外向环性 恃强性-谦逊顺从 实验性-自由激进
解释	高8低3
优缺点	人才选拔
其他	只选一个，不漏不中 无时间限制 个别、根源、素质

二、EPQ 艾森克人格问卷

(一) EPQ测验的实施

测验名称：Eysenck Personality Questionnaire，简称EPQ

编制者：艾森克及其夫人

测验功能：人格

题目数量：88个题目，是非式（分为成人和幼年两套问卷）

四个量表：精神质（P）、内外向（E）、神经质（N）、说谎（L）

适用范围：成人版用于16岁以上，幼年版用于7-15岁

施测形式：问卷式（个别、团体）

填写方式：自评

编制方法：因素分析法

(一) EPQ测验的实施

E 内外向	与中枢神经的兴奋、抑制的强度有关	高分外向，好交际，渴望刺激 低分内向，喜静内省，有秩序
N 神经质	与植物性神经的不稳定性有关 (高分易兴奋；低分难兴奋)	高分焦虑抑郁，情绪强烈 低分稳重温和，善于自控
P 精神质	根据正常人和病人的特质筛选而来 与社会适应有关	高分孤独冷酷，难以适应 低分态度温和，善从人意
L 说谎	效度量表 测量受测者的掩饰倾向或淳朴性	儿童，年龄增加，L分降低 成人，年龄增加，L分升高

(二) EPQ测验的记分

EPQ的施测过程		
指导语		说明问卷填写方法、注意事项等
填 写		每题两个选项，勾选“是”或“否”
记分	获得原始分	按规定进行二分记分
	转换导出分	通过查表，将各分量表的原始分转换标准T分 再将各量表T分数登记在EPQ剖析图和 EN关系图 上
解 释		 典型型 倾向型 中间型 倾向型 典型型 38.5 43.3 50 56.7 61.5 T分数

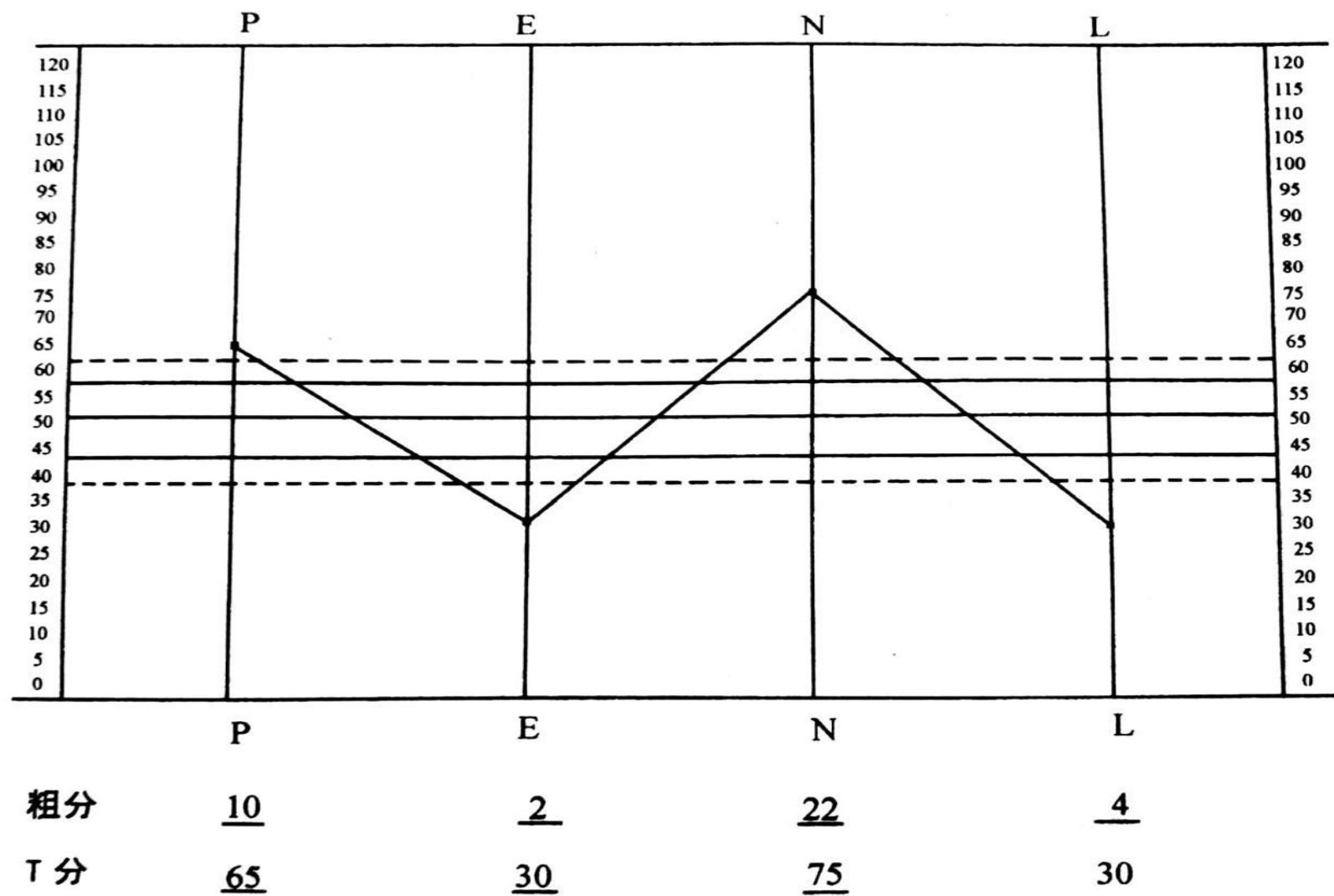
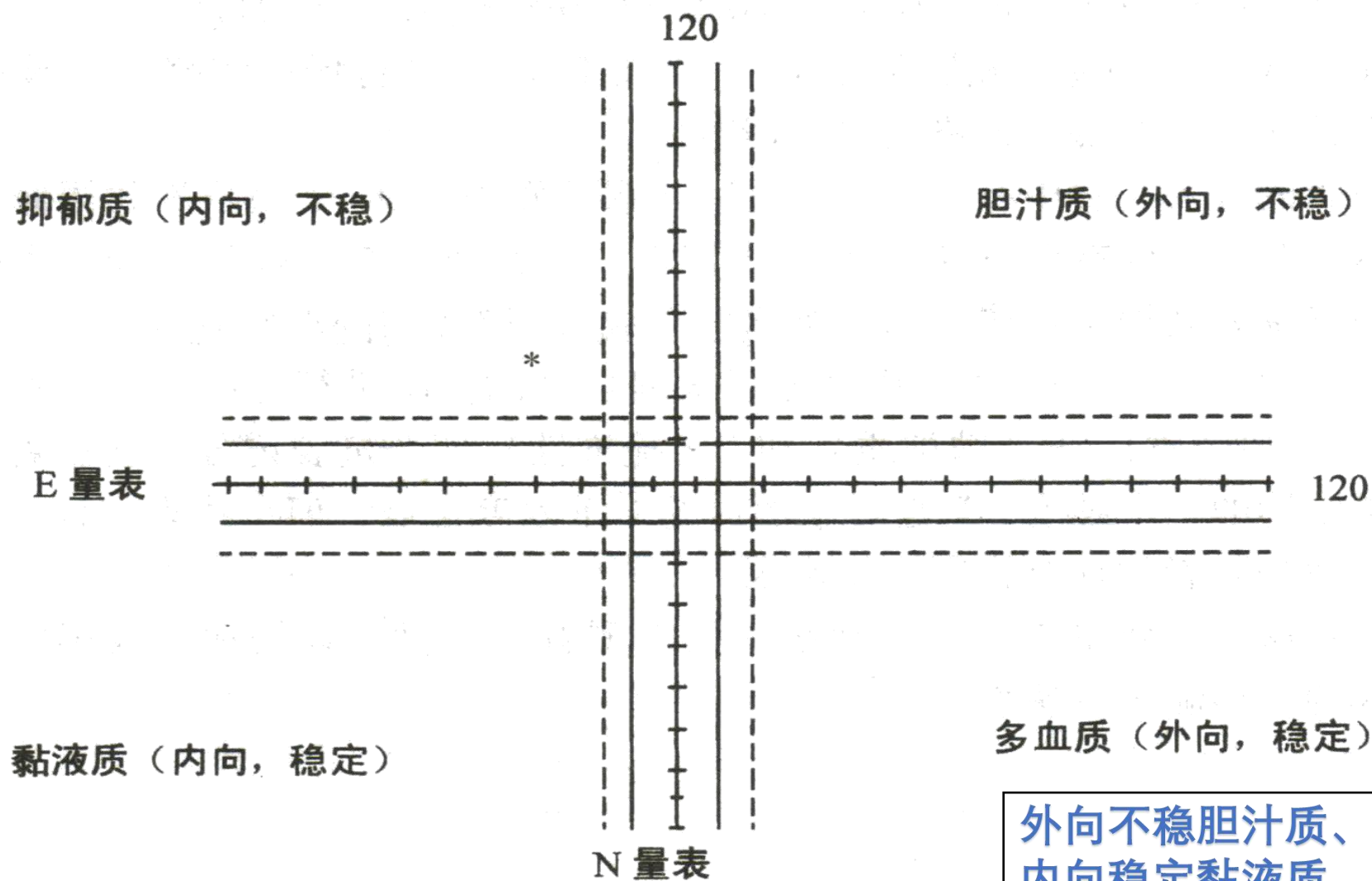


图 3-16 EPQ 量表剖析图



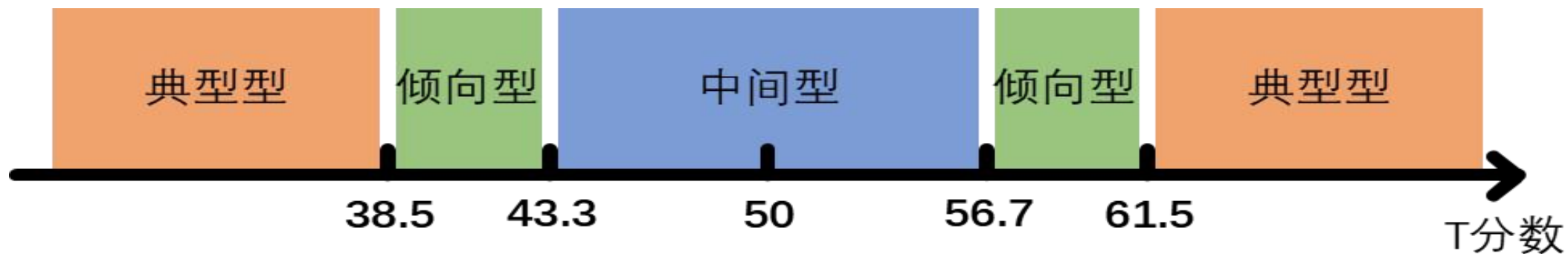
外向不稳胆汁质、外向稳定多血质
内向稳定黏液质、内向不稳抑郁质

图 3-17 E 和 N 的关系图

多选

考点P121

(三) EPQ结果的解释



典型内向	倾向内向	中间型	倾向外向	典型外向
38.5分以下	38.5-43.3分	43.3-56.7分	56.7-61.5分	61.5分以上

测验名称	MMPI	16PF	EPQ
中文名称	明尼苏达多相人格测验	卡氏16种人格因素测验	艾森克人格问卷
题目数量	566，16个重复，前399	折中是非题	
适用范围	年满16岁，小学以上文化	相当于初中以上	成人版-16岁上，幼年版-7岁上
编制方法	经验效标法	因素分析法	因素分析法
评定范围	以现在为准	以现在为准	以现在为准
量表内容	4个效度量表：QLFK 10个内容量表	16种根源特质 乐群性-外向环性 恃强性-谦逊顺从 实验性-自由激进	E-内外向 N-神经质 P-精神质 L-说谎
解释	中60美70	高8低3	中间型、倾向型、典型型
优缺点	临床符合、首次效度 题多时长，文化影响	人才选拔	
其他	Q: 高分逃避现实，566-30,399-22 L: 原始分超过10，无效 F: 有效高分，严重精神病 无效高分，不认真、装病	只选一个，不漏不中 无时间限制 个别、根源、素质 特殊演算公式	38.5 43.3 56.7 61.5 EN关系图，气质类型





应激以及相关问题的评估

社会关系与心理健康密切相关，缺乏社会支持是产生心理问题的原因之一。

亲密和可信任的关系是压力的有效缓冲器



一、生活事件量表（LES）

（一）LES测验的实施

测验名称：生活事件量表（Life Event Scale），简称LES

测验功能：对精神刺激进行定性和定量，评定生活事件及其影响

题目数量：48个项目（包括家庭生活28条、工作学习13条、社交及其他方面7条）

适用范围：16岁以上正常人、神经症、心身疾病、各种躯体疾病以及自知力恢复的重性精神病患者

施测形式：自评

评定范围：某一时间范围内（通常为一年内）

一、生活事件量表（LES）

考点P125

（三）LES结果的解释

总分越高反应个体承受的精神压力越大

- **95%**的正常人，一年内的LES总分不超过**20**分
- **99%**的正常人，一年内的LES总分不超过**32**分

二、社会支持评定量表（SSRS）

（一）SSRS测验的基本信息

测验功能：评定社会支持，采用客观支持和主观支持二分类的社会支持理论

题目数量：10个项目（包括客观支持3条、主观支持4条和对社会支持的利用度3条）

时间范围：考虑各项目的要求

适用范围：了解受测者社会支持的特点及其与心理健康水平、各种疾病的关系

实测步骤：实施测验时，请受测者按各个问题的具体要求，根据实际情况填写，并要求其合作。

二、社会支持评定量表 (SSRS)

(二) SSRS测验的记分

1. 条目记分方法 (3种)

(1) 第1-4,8-10条, 记1、2、3、4分

(2) 第5条, 分A、B、C、D、E五项记总分, 每项从“无”到“全力支持”分别计1-4分

(3) 第6,7条如回答无任何来源计0分, 回答“下列来源”者, 有几个来源记几分

2. 统计指标 **总分和维度分** (客观支持分、主观支持分、对支持的利用度)

三、应对方式问卷（CSQ）

（一）CSQ测验的基本信息

测验功能：解释个体或群体的应对方式类型和应对行为特点；

比较个体或群体的应对行为差异；

反映人的心理发展成熟程度

编制者：肖计划

题目数量：62个项目

包括**6个因子**：退避、幻想、自责、求助、合理化、解决问题

(一) CSQ测验的基本信息

各分量表意义：六个应对因子排出下列关系序列图：

退避-幻想-自责-求助-合理化-解决问题

适用范围：14岁以上，初中及以上

时间范围：近两年

记分方法：**因子分**

四、防御方式问卷 (DSQ)

防御方式问卷 (DSQ)

- ▶ 目的是能收集较完整的防御机制资料，适用于正常人及各种精神障碍
- ▶ **共包括88个项目，包括比较广泛的防御行为：即从成熟的直到不成熟的，共分为4个因子**
- ▶ 因子1：不成熟的防御机制：投射、被动攻击、潜意显现、抱怨、幻想、分裂、退缩、躯体化
- ▶ 因子2：成熟防御机制：升华、压抑、幽默
- ▶ 因子3：中间型防御机制：反作用形成、解除、制止、回避、理想化、假性利他、伴无能之全能、隔离、同一化、否认、交往倾向、消耗倾向、期望
- ▶ 因子4：掩饰因子

每个项目均采用1-9的九级评定方法，较为细致

总结

测验名称	LES	SSRS	CSQ
中文名称	生活事件量表	社会支持量表	应对方式问卷
测验功能	对精神刺激进行定性和定量 评定生活事件及其影响	评定社会支持	解释个体或群体的应对方式类型 和应对行为特点 比较个体或群体的应对行为差异 反映人的心理发展成熟程度
量表内容	家庭生活、工作学习、社交 及其他		退避-幻想-自责-求助-合理化-解 决问题
记分		条目记分方法3种	因子分
评定范围	一年内		
解释	95%一年内总分不超过20 99%一年内总分不超过32		

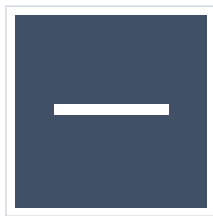
第五节 个案概念化



个案概念化在心理咨询中的作用



个案概念化的步骤及模型



个案概念化在心理咨询中的作用

多选

考点P135

一、个案概念化在心理咨询中的作用



含 义

个案概念化，是用**某种理论假设**来描述、**梳理、理解来访者心理问题**的过程。

作 用



- ▶ 是心理咨询中必不可少的思维工具
- ▶ 是对来访者认知、人际、行为等问题原因的假设
- ▶ 是促发因素以及影响后果的一系列假设

二、不同流派的个案概念化

咨询师与来访者进行初步接触时，所持有的**理论观点**决定了咨询师所**寻找并看到的问题**。而这也大体上决定其咨询过程的焦点和进程。并进而影响其咨询策略和步骤的选择。

对于来访者问题产生的原因，**每一种理论流派都会有不同的看法**，所以也就会形成有差异的个案概念化模式。

二、不同流派的个案概念化

- ▶ 不同的原因分析又会让咨询师**采取不同的咨询方法**，所以前提就是对这些问题的根据某些理论来形成假设。
- ▶ 对于来访者所表现出的各种问题产生的原因，每一种个案概念化模式都有不同的看法

理论假设→问题→原因分析→咨询方法

“灵活”

常用的理论取向

1. 精神分析取向疗法
2. 阿德勒疗法
3. 存在主义疗法
4. 来访者中心疗法
5. 格式塔疗法
6. 行为主义疗法
7. 认知行为疗法
8. 现实疗法
9. 后现代主义疗法
10. 家庭系统疗法

多选

考点P136

(一) 精神分析取向疗法

精神分析理论认为，人们会受到**无意识动机、冲动与压抑之间的冲突、防御机制和早期经验**的重大影响。

假设：个体健康人格的形成源自于个体在性心理与社会心理上的良好发展。如果个体没有处理好特定的发展冲突，那么个体的人格就会存在一定的缺陷。

多选

考点P136

(二) 阿德勒疗法

阿德勒疗法认为，人是社会性的，会受到社会力量的影响和激发。

人类的本性是创造性的、主动性的、决策性的。

注重个体的整体性以及对个体主观想法的了解。倾向于进行结构化的评估过程，采用关注来访者生活方式细节的问卷，收集原生家庭的资料等。

(三) 存在主义疗法

存在主义理论认为，我们通过自己的选择去定义自我。了解个体的唯一方式就是要深入个体的主观世界。

“存在先于本质”

评估的主要目的就是**要了解来访者用来构建自身存在的假设。**

(四) 来访者中心疗法

来访者中心疗法理论认为，我们有了解自己问题的能力，我们自己也具有解决这些问题的资源。

必须注重来访者本身的建设性以及健康的一面。

传统的评估与诊断没有意义，因为这些都是从外部理解来访者的方式。

(五) 格式塔疗法

格式塔疗法基本假设是：个体和自己的行为只有在其所处的环境中才能被充分理解。

“未完成事件”

帮助来访者探索其内心（内在）世界以及外界环境。格式塔疗法的心理咨询师会**收集来访者的特定信息以弥补评估方面的不足。**

六、行为主义疗法

行为主义疗法基本假设是：从根本上讲，**每个人都在被学习以及社会文化的条件作用所塑造**。相信个体有能力消除自己的适应不良行为并重新获得建设性的行为。

对来访者当前的机能进行综合性的评估，旨在探讨那些影响来访者当前行为方式的错误学习过程。

强调条件反射的形成

多选

考点P137

七、认知行为疗法

认知行为疗法基本假设是：问题来源于我们的想法以及我们对生活情景的观点，因此需要改变那些导致我们行为问题的自我挫败性的想法。

认知行为法采用的评估过程旨在**了解来访者的思维方式，重视来访者针对某些事件所发展起来的各种信念。**

八、现实疗法

现实疗法的假设是：所有的问题都存在于当前，必须在当前加以解决。问题症状都是个体想要处理当前不满意人际关系而引起，那么改善个体的重要人际关系，问题也将随之消失。

通过技巧性提问来帮助来访者对其现有行为进行评估，帮助来访者以批判性的观点审视自己的现有行为，并评估这些行为的有效性。

九、后现代主义疗法

后现代主义疗法的假设是：人们都是健康且有能力的，他们有能力找到处理困境的方法，而每人都是自己生活的专家。

不强调对个体进行评估和分类，在咨询过程中将来访者作为起主导作用的角色，不会抓住来访者的问题不放，而是**将注意力放在来访者的能力和可利用的资源上。**

十、家庭系统疗法

家庭系统疗法的假设：只有在家庭的背景下才能对个体进行充分的理解。

系统中某个部分的改变将改变该系统中的其他部分，如果家庭单位中出现了显著的变化，那么这个变化将会对个体本身造成深远的影响。





个案概念化的步骤及模型

一、个案概念化的步骤

个案概念化是一个**持续的过程**，在咨询中会不断地修正对个案的理解

- 1.收集资料**：收集资料，确认主要问题，评估功能水平
- 2.整理资料**：归纳整合，思考产生机制及影响机制
- 3.理解资料**：运用理论理解问题，初定咨询目标、方法和技术



二、认知行为疗法个案概念化模型

认知行为疗法认为，个案概念化是所有心理咨询师都要学习的一项重要技能。

裴森（Persons）提出了进行个案概念化的**四个要素**：（治疗师的指南针）

- 1.建立问题清单，包括主要症状与问题
- 2.确认产生这些障碍或问题的机制
- 3.确认激活当前问题的诱发因素
- 4.考察当前问题在来访者早期经历中的起源

三、心理动力学个案概念化的三个步骤

心理动力学个案概念化认为，当一个人遇到困扰并前来接受心理咨询时，其**原因在于个体的潜意识的想法和情感**。因此，帮助来访者意识到他们潜意识中的想法和情感，而且要理解这些潜意识中想法和情感是如何发展出来的，以及为什么会出现，这是一项重要的心理动力学技术。

多选

考点P142-144

三、心理动力学个案概念化的三个步骤

心理动力学的个案概念化**可帮咨询师理解来访者怎样以及为什么会形成他们的特定的思考、感受和行为模式。**

这一过程包括**三个基本步骤**：

1.描述来访者的问题和模式

2.回顾来访者的成长经历 → → → → →

3.在问题和模式与成长经历之间建立联系

- 考虑自然因素和环境因素
- 关系的关键性
- 心理创伤的决定性
- 事件发生年龄的相关性
- 人的毕生发展

总结

个案概念化

定义：用某种理论假设来描述、梳理、理解来访者心理问题的过程
理论假设→问题→原因分析→咨询方法

作用--思维工具、对问题因果的假设

常用理论取向

- 精神分析--无意识动机、冲动与压抑、防御机制和早期经验
- 阿德勒--结构化评估、生活细节和原生家庭
- 存在主义--构建自身存在
- 来访者中心--无条件积极关注、外部评估无益
- 格式塔--收集特定信息
- 行为主义--综合评估机能
- 认知行为--思维信念
- 现实疗法--关注当下
- 后现代--能力和资源
- 家庭系统--“牵一发而动全身”

个案概念化的步骤--收集、整理、解释；认知四要素，动力三步骤

THANKS



专业科普



大众心理